なぜACPはうまくいかないのか

3ステージ・4つの質問・予後の伝え方

聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

病状 → ゴール → 選択肢の順に話す
いちばん多い失敗は、ゴールの段を飛ばすこと

2

選ばせず、価値観の上に提案する
提案の強さは、確かさ・価値観・委ねたい気持ちで変える

3

ACPは書類ではなく、価値観の共有
明るい質問から上限と下限を探り、家族と分かち合い続ける

出典：中川俊一『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』（メジカルビュー社 2024）・m3.com連載

はじめに

重い話し合いは、順番と聞き方でこじれる

悪い人がいるからではない

聖路加国際病院 集中治療科

この聞き方、していませんか

「心臓マッサージは希望しますか」

病状を伝えた直後に、処置の希望を聞く

「透析は家族で決めてください」

決断の重さを、家族に預けてしまう

「どうしますか？」

中立に見えて、決断を丸投げしている

どれも、本人が何を大切にしているかを聞く前に、選択を迫っている

出典：中川俊一『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』（メジカルビュー社 2024）・m3.com連載

第 1 章

01

3ステージ

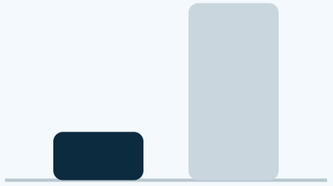
病状 → ゴール → 選択肢。順番がすべて

重い会話は、3つの段で進める

1st
病状の説明
医療者が主

2分程度で、現状と
見通しを伝える

2nd
治療ゴールの設定
患者・家族が主



何を大切にし、何を
恐れるかを聴く

3rd
治療オプションの相談
医療者が主

ゴールを医療行為に
翻訳して推奨する

■ 医療者　■ 患者・家族

棒の高さは主導の度合いを示す模式図（数値ではない）

出典：中川俊一『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』（メジカルビュー社 2024）・m3.com連載

いちばん多い失敗は、2ndを飛ばすこと

はい／いいえで始めると、終わらない

- CPRに「いいえ」と答えても、質問は次々に続く
- 抗菌薬・昇圧薬・人工栄養・透析・採血・画像…
- 医学の素人である家族には、**答えようがない**
- 1stはこなせても、2ndを飛ばしてしまう

心肺蘇生 はい いいえ

抗菌薬 はい いいえ

昇圧薬 はい いいえ

人工栄養 はい いいえ

透析 はい いいえ

採血・画像 はい いいえ

出典：中川俊一『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』（メジカルビュー社 2024）・m3.com連載

「どう生きるか」で決める

12%未満

長期の人工呼吸のあと、1年後に**自立して暮らせる**人の割合
（Nelson AJRCCM 2010）

元の機能に戻れないなら、治療を望まない人が多い
Fried NEJM 2002

だから、ゴールを先に聞く
救命の先で、どう暮らせるかで決める

出典：Nelson AJRCCM 2010、Fried NEJM 2002（連載で引用）

たとえ話

よい店員は、まず「何に使いますか」と聞く

選ばせる前に、目的を聞く

聖路加国際病院 集中治療科

SDMを、パソコン選びで考える

店員1

「これが間違いない」

使い道を聞かずに1台を勧める

パターナリズム

店員2

性能の数字を
並べて選ばせる

素人には判断材料にならない

情報を浴びせて委ねる
＝「CPRを希望しますか」

店員3

使い道と予算を
聞き、1台を勧める

前半が2nd、後半が3rd

ゴールを聞いてから推奨

SDMは、段階ごとに**主導する側が入れ替わる**こと（Elwyn BMJ 2010）

出典：中川俊一『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』（メジカルビュー社 2024）・m3.com連載

第 2 章

02

提案と誘導

選ばせずに提案し、強さを変える

「どうしますか」をやめ、推奨してから聞く

これまで

「◯◯はどうしますか？」

中立に見えて、決断を相手に預けている

→

これから

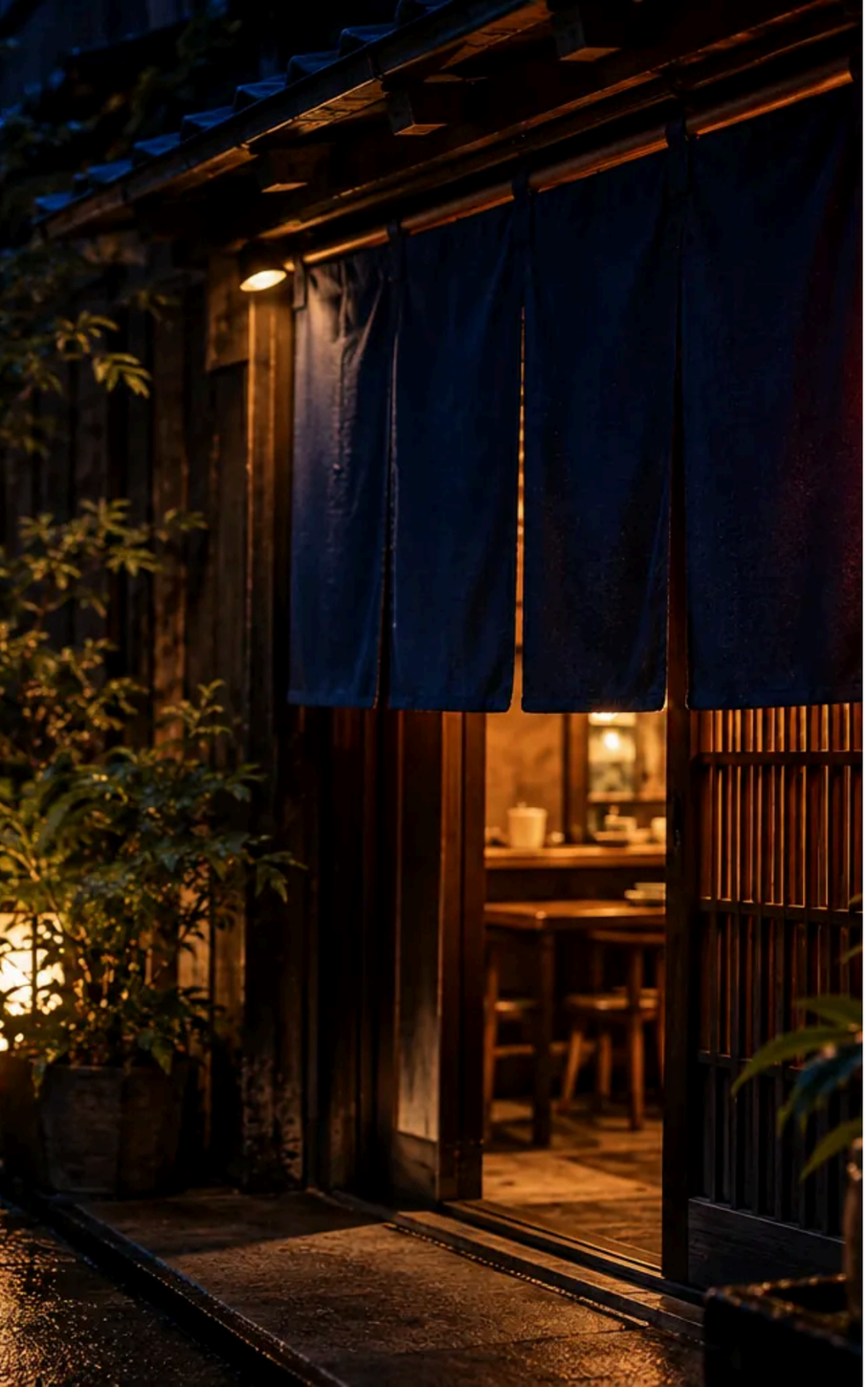
「しないほうがいいと思います」

「いかがですか？」

推奨を先に述べ、そのあとで意見を聞く

「しない」と決める重さは、医療の素人には大きい。その重さを医療者が引き受ける

出典：中川俊一『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』（メジカルビュー社 2024）・m3.com連載



中立な問いは、選ぶ価値を匂わせる

居酒屋のたとえ

ひどい店の話をしたあとで

「そこ行きたい？」

と聞くのは不自然

ICUでは

無益だと説明したあとで

「CPRはどうしますか」

と聞くのも同じ

中立な問いは、その選択肢にも
検討する価値があると伝えてしまう

出典：中川俊一（メジカルビュー社 2024）・m3.com連載

提案と誘導を分けるのは、価値観の土台

2ndを飛ばす	→	「CPRはしないほうがいい」	→ 誘導
価値観を聴いた「もう苦しみたくない」	→	「CPRはしないほうがいい」	→ 提案

同じ言葉でも、順番で意味が変わる。提案は、価値観を医療行為に翻訳すること

出典：中川俊一『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』（メジカルビュー社 2024）・m3.com連載

提案の強さは、4段階

●●●●	informed assent	「○○はしません」	無益が明らかで、 価値観もはっきりしている
●●●○	推奨して意見を聞く	「しないほうがいいと思います」	推奨ははっきり、 決定は一緒に
●●○○	やや弱い推奨	「おすすめしません」	医学的な見込みに幅が あるとき
●○○○	中立に尋ねる	「○○はどうしますか」	ゴールに寄与しないと 分かっているなら使わない

強い：医療者が重さを引き受ける

弱い：決断を相手に預ける

出典：中川俊一（同上）、informed assent は Curtis JAMA 2020

強さを決めるのは、3つの要素

1	2	3
医学的な確かさ 無益なことが、 どこまで明らかか	**価値観の明確さ** 本人が何を大切に するかが、聴けているか	**委ねたい気持ち** 家族が、決定を医療者に 委ねたいか

そろうほど**強い側**へ。価値観が
聴けていなければ、**提案の前に2ndへ戻る**

informed nondissent：方針を示し、
反対なら言ってもらう（AHA 2025）。assent
と同じく強い側

出典：中川俊一（同上）、AHA 2025（倫理）、Curtis JAMA 2020

第２章のまとめ

決める重さは、医療者が引き受ける

価値観を聴いたうえで、強さを変えて提案する

聖路加国際病院 集中治療科

第 3 章

03

ACPと4つの質問

書類より、価値観の共有

事前指示書が効くには、7条件がすべて要る

A	B	C	D	E	F	G
本人が価値観をわかっている	代理人を決めている	代理人が価値観を知っている	書類にしている	その場に書類がある	代理人がその場にいる	医師が話し合いを適切に進める

1つでも欠けると、実際の場面では効かない

出典：中川俊一『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』（メジカルビュー社 2024）・m3.com連載

9割ずつそろっても、7つ全部は約半分

48%

各条件が**90%**で満たされても、
7つそろう確率

0.9 の 7乗

0.8%

各条件が**50%**なら、7つそろう確率

0.5 の 7乗

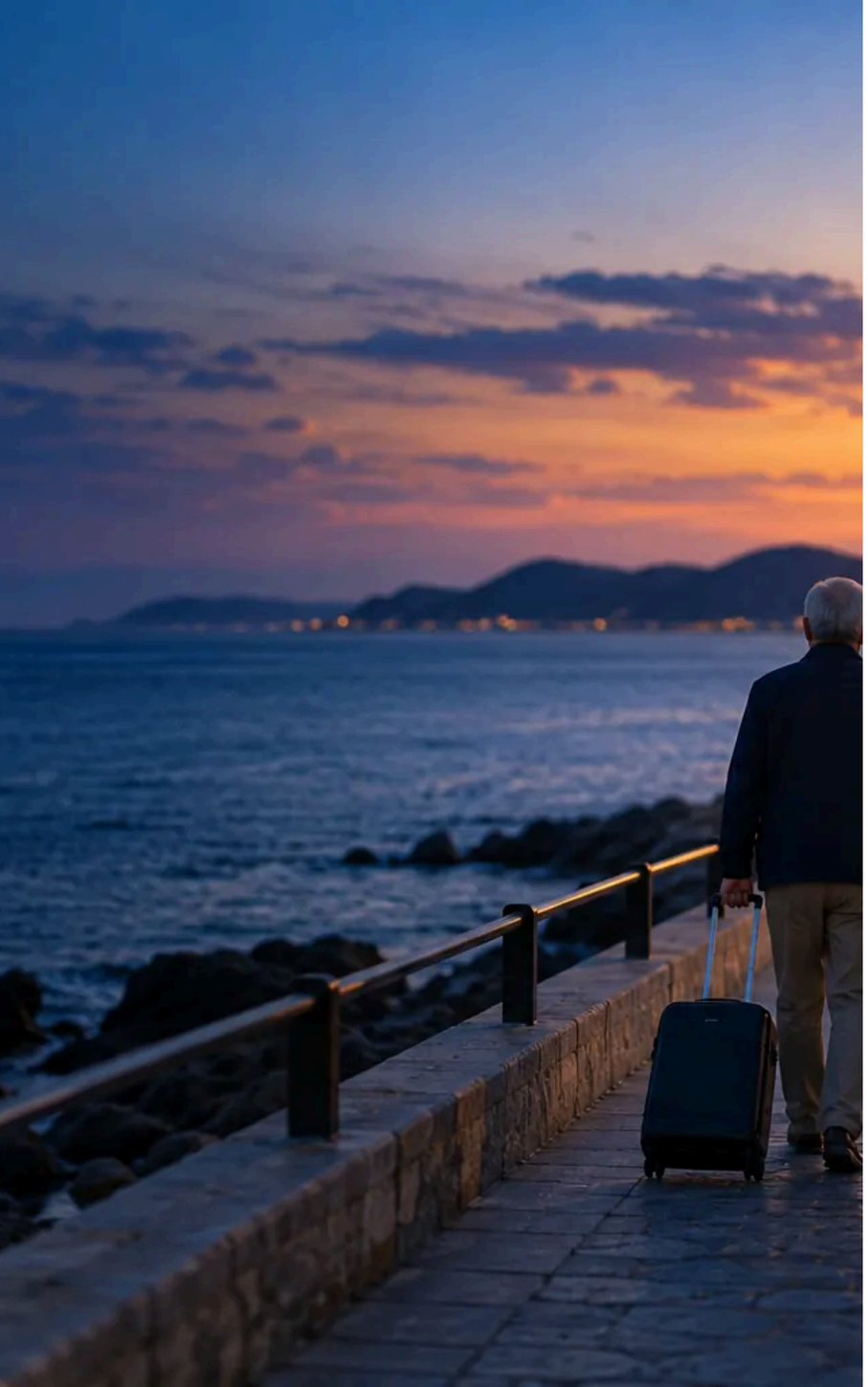
書類を作れば安心、とはならない。力を注ぐ先は価値観の共有

出典：中川俊一『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』（メジカルビュー社 2024）・m3.com連載

書類が、会話を止めることもある

よくある失敗	Aを経ずにDだけ作る。勧められて書いたが、**内容を覚えていない**
逆効果	「もう話さなくていい」となり、家族が本人の思いを知る機会を失う（Auriemma 2022）
Gで崩れる	A〜Fがそろっても、挿管の判断を迫られて書類どおり答えられる家族は少ない
法的効力	効力があっても、家族が**納得しなければ機能しない**

出典：中川俊一（同上）、Auriemma JAMA Intern Med 2022



理想のACPは、価値観の共有

根幹

本人が自分の価値観を言える

ここは譲れない

共有

できるだけ多くの家族と共有する

代理人を1人決めるより大事

書類

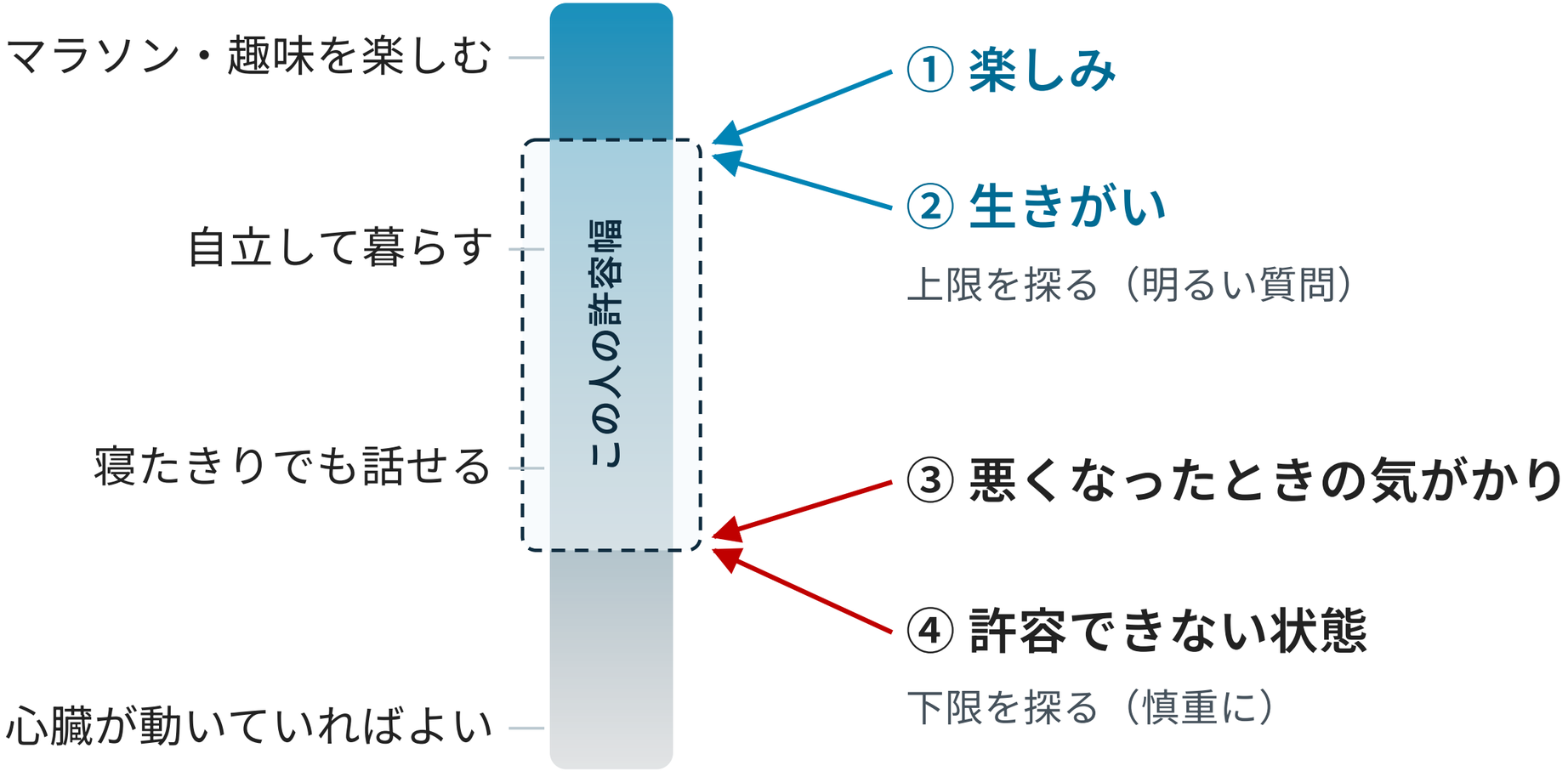
事前指示書のことは忘れてよい

元気なうちに3rdまで決めるのは難しすぎる

ACPは、イベントではなくプロセス

出典：中川俊一（メジカルビュー社 2024）・m3.com連載

人生の状態は、白黒ではなくグラデーション



出典：中川俊一『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』（メジカルビュー社 2024）・m3.com連載

最初の問い

「いま楽しみにしていることは？」

答えやすい問いから、上限を探る

聖路加国際病院 集中治療科

4つの質問は、明るい順に聞く

順	尋ねること（要旨）	狙いとコツ
① 楽しみ	いま楽しみにしていること	上限を探る。答えられない人はまずいない
② 生きがい	人生を意味あるものにしていること	詰まったら「大切なこと」に言い換える
③ 気がかり	**悪くなったとき**の一番の気がかり	「今」ではなく、前置きを意識して添える
④ 許容できない状態	こうなったら生きていたくない状態	伝わらなければ具体例を挙げる

出典：中川俊一『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』（メジカルビュー社 2024）・m3.com連載

ICUでは4つ目を使わず、2ndの問いで探る

死が迫った場面では、
文脈に合わない

4つ目の問いは、元気なうちの
ACP向け。ICUの家族面談では、
ほかの問いで下限を探る

ICUの2ndステージで使う問い（要旨）

- 今の話を聞いて、一番の気がかりは
- ご本人が大切にしてきたこと
- 元気だったころの楽しみ
- 以前、悪くなったときの話をしたか
- ご本人がこの状況を知ったら、何と言うか

出典：中川俊一『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』（メジカルビュー社 2024）・m3.com連載

第 4 章

04

難しい場面

予後・「言わないで」・時間がない

「死ぬんですか？」には、答えてから黙る

1　率直に答える	はぐらかさない。お別れの時が近づいている、と**シンプルに**伝える
2　沈黙する	気まずさから、要らない情報を**話し足さない**。典型的な失敗
3　聞き返して逃げない	説明したあとで「どうして？」と返して答えないのは、ずるい

出典：中川俊一（メジカルビュー社 2024）・m3.com連載

「どれくらい？」には、5段階で答える

1
許可
伝えてよいか
確かめる

2
前置き
正確ではないが
目安は示せる

3
単位
時間の単位で
答えると伝える

4
答え
ゆっくり、
前後に沈黙

5
感情
感情に名前を
つける

数時間〜数日	**数日〜数週**	数週〜数か月	数か月〜数年

「わかりません」で済ませるのは不誠実。**どの単位かの見当がつかないことは、ほとんどない**

出典：中川俊一（同上）。5段階は伊藤・大内『緊急ACP』の型

「本人には言わないで」には、まず家族の心配を聴く

1

家族の心配を聴き、感情に応える
希望を失う、落ち込む。NURSE で応える（Name・Respect など）

2

話さないほうが、不安は強まる
何が起きているか分からないことは、悪い知らせを知るより辛い（Wright JAMA 2008）

3

家族と一緒に、本人に聞く
「皆さんに伺っているのですが」と一般化し、どこまで知りたいかを尋ねる

4

拒まれたら、一番の気がかりを聞く
病状を尋ねてきたら、もう逃げない。「特にない」なら家族と相談してよいか了承を得る

出典：中川俊一（同上）、Wright JAMA 2008

時間がない

1時間の電話より、5分の正しい順番

ERの実例から

聖路加国際病院 集中治療科

時間がないときほど、2ndを削らない

ニューヨークのER（COVID-19流行期）

90歳・転移性肺がん。
レジデントが1時間電話で話しても、息子さんは「全部やって」のまま

5分

1st → 2nd → 3rd の順で、合意に至った

医師 **1st** どうやっても助けられない、とはっきり伝える

医師 **2nd** 「一番の気がかりは何ですか」

息子さん 「母は苦しいのですか」

医師 **3rd** 苦痛をとる薬を使い、機械やチューブにはつながない方針を推奨

2ndは慣れれば2〜3分。飛ばすと「生きるか死ぬか」の判断になり、挿管・透析・昇圧薬・CPRまで全部行われる

出典：中川俊一『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』（メジカルビュー社 2024）・m3.com連載

第 5 章

05

反復とスキル

オウム返しをやめ、磨き方を決める

オウム返しをやめ、理由を聞く

オウム返し

「もう良くならないと…」

語尾だけ変えて繰り返すと、相手は苛立つ。否定も励ましも、価値観の押しつけになる

Tell me more
もう少し教えて

Why?
どうしてそう思う

What else?
ほかには

理由が分かれば打つ手が変わる。
症状がとれていないのか、病状を誤解しているのか

出典：中川俊一『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』（メジカルビュー社 2024）・m3.com連載

スキル

面談のたびに、学びを1つ書く

1回5分で、確実にうまくなる

聖路加国際病院 集中治療科

コミュニケーションは、手術手技と同じスキル

1 指導医を真似る → 2 自分の言葉に直す → 3 辛口の評価を頼む → 4 学びを1つ書き留める

どれも誤り

- センスで決まる
- 教えられない
- 経験を積めば自然にうまくなる

1回5分で済む

面談を「終わらせられる」ことは、**質の保証にはならない**

出典：中川俊一『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』（メジカルビュー社 2024）・m3.com連載

ICUの家族面談は、この3手で

1st
2分サマリー
現状と見通しを
曖昧にせず

→

2nd
一番の気がかり
価値観を聴く

→

3rd
ゴールに沿った推奨
informed assent を含む

DNARは、はい／いいえで聞かない
DNARの対象は心停止時のCPRだけ。ほかの治療を控える意味ではない

予後は、時間の単位で
特定の数字は使わない。どの単位かは、ほぼ見当がつく

出典：中川俊一『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』（メジカルビュー社 2024）・m3.com連載

ご清聴ありがとうございました

次の面談で、学びを1つ書き留めてください

聖路加国際病院 集中治療科

出典

書籍と連載

- 中川俊一『あなたのACPはなぜうまくいかないのか？』メジカルビュー社、2024年
- 中川俊一、m3.com 臨床ニュース連載（全10回、2024年12月〜2025年2月。上記書籍より転載）

連載で触れられた文献

Nelson AJRCCM 2010／Fried NEJM 2002／Elwyn BMJ 2010／Curtis JAMA 2020／Auriemma JAMA Intern Med 2022／Wright JAMA 2008／AHA 2025（倫理）／伊藤・大内『緊急ACP』

このスライドは連載・書籍の論点を整理した要約で、原文の転載ではありません。言い方はすべて要旨です。